

AFMCP Chap6 소통·호르몬 균형: 치료적 개입과 임상 플로우 경로 Part 3

Communication and Hormone Balance — 한국어 번역

치료적 개입: 기초 치료 강조

이제 치료적 개입을 다룰 시간입니다. AFMCP이기 때문에 기초 치료를 강조합니다. 환자들은 만성 스트레스로 인해 압도되어 있어, 생활습관 및 식이 변화에 참여하기 어렵습니다. 따라서 항상 '환자에게 중요한 것이 무엇인가'라는 첫 번째 질문으로 시작하는 것이 중요합니다. '환자의 문제가 무엇인지'는 파악했지만, '환자에게 무엇이 중요한지', '환자의 목표는 무엇인지'를 파악해야 합니다.

협력 치료팀 구성

부신 조절 이상은 팀 접근이 필요합니다:

- 사회 서비스 제공자: 건강의 사회적 결정요인으로 인한 '웨더링' 완화에 필요
- 코치(Coach): 동기 부여 및 생활습관 변화 지원
- 영양 전문가: 영양 결핍 해소
- 상담사·정신건강 전문가: 만성 코르티솔 → 인지·정신건강 문제 시

질문 진주(Question Pearls) — 빠른 임상 도구

시간이 부족할 때 활용할 수 있는 효과적인 질문들:

- '과거 습관과 행동 중 건강에 부정적인 것과 긍정적인 것은 무엇인가요?'
- '___을 덜 하면 건강이 더 좋아질 것 같아요.' (___을 채워보세요)
- '___을 더 하면 건강이 더 좋아질 것 같아요.' (___을 채워보세요)

→ 환자 자신이 건강의 전문가입니다. 이 질문들을 통해 환자의 맥락과 환경을 간접적으로 파악할 수 있습니다.

IFM 툴킷 자원 활용

- '만성 스트레스의 영향(Effects of Chronic Stress)' 교육 자료
- 감사 일기(gratitude journal) 작성 시작 방법
- 명상(meditation), 스트레스 변환 통합 전략
- 부신 기능 최적화를 위한 적당한 운동 활용법
- 수면 개선 제안

생활습관 개입 — 이완 기법

호흡(breathing)은 매우 효과적이고, 안전하고, 저렴한 기법입니다. 진료실에서 바로 할 수 있습니다. 만성 부신 조절 이상 환자라면 누구에게나 호흡 기법 수련을 권장하세요.

- 다양한 이완 기법: 호흡, 명상, 바이오피드백, 마음챙김
- 스트레스 관리 개입이 '일반적 치료'보다 코르티솔 조절에 효과적 (연구 근거)
- 정신건강: 부신 조절 이상 환자에서 항상 정신건강 영향을 확인하세요
- 관계: 환자의 가족·친구·반려동물 포함 지지 네트워크 활용
- 의사 자신도 치료 파트너십에서 치료적 역할을 합니다

식이 개입 — 빠른 질문 도구

음료 질문부터 시작하기 (칼로리 있는 음료는 거의 항상 HPA 축 자극):

- '___를 덜 마시면 건강이 더 좋아질 것 같아요.'
- '___를 더 마시면 건강이 더 좋아질 것 같아요.' (녹차, 레몬·라임 물 추천)
- '___를 덜 먹으면...' / '___를 더 먹으면...' 도 같은 방식으로

부신 조절 이상 식이 원칙: 핵심 식품 계획(Core Food Plan) + 파이토뉴트리언트 스펙트럼 + 저혈당 지수 + 항염식 + 저가공식품

부신에 필요한 핵심 영양소

- B 복합 비타민 (많은 부분이 동물성 식품에서 유래 — 특정 환자에게 도전적)
 - 비타민 C (카테콜아민 합성에 필수)
 - 마그네슘 (부신 조절 이상에서 특히 많이 소모)
 - 아연, 판토텐산(B5), 필수 지방산
- 식품으로 먼저, 보충제는 식품이 불충분할 때만

장 건강(DIGIN/5R)과 부신

모든 만성 스트레스 환자에서 DIGIN을 반드시 다루어야 합니다. DIGIN의 'N' — 장-뇌 축(gut-brain axis), 장신경계, 미주신경(vagus nerve) — 은 HPA 축 환자에서 특히 집중적으로 다루어야 합니다.

★ 제거(Remove)와 재균형(Rebalance) — 매트릭스 어디서보다 부신 조절 이상에서 가장 중요합니다.

핵심 임상 교훈

부신에게 의미와 목적을 묻는다면: '스트레스 환경에 반응하고 최적으로 기능할 수 있게 해주는 것.'
부신이 의사에게 요청하는 것: '환자가 스트레스 환경을 완화·변화·회피할 수 있도록 도와주세요.'

- 보충제로는 해결 안 됩니다 — '보충제로 환경을 바꿀 수 없습니다'
- 환경을 바꾸는 것이 부신이 하는 일을 치료적으로 바꿉니다
- 호흡처럼 단순한 기법들이 인식을 바꾸고 부신 기능을 개선합니다

임상 플로우 경로

1단계: 임상 소견 파악 (코르티솔 과잉/결핍 증상·징후 목록)

→ 다발성 만성 질환 환자 = 즉시 부신 조절 이상 의심

2단계: ATM 파악 — STAINS 기억법 사용

→ 내부·외부 환경 모두 고려

3단계: 환자 이해 가능한 언어로 기능 이상 설명 생성

4단계: 환자와 함께 개입 우선순위 결정

→ 환자가 할 수 있는 것과 선호에 맞게 조정. 초반에 온화하게 시작

5단계: 식이 개입 — 핵심 식품 계획, 파이토뉴트리언트, 저혈당, 항염, 저가공

6단계: 필요 시 의뢰 — 사회 서비스, 코치, 영양사, 정신건강 전문가

7단계: 생활습관 — 수면 위생, 호흡 기법, 관계, 적당한 운동

8단계: 장 건강 — DIGN/5R (이전 개입으로 효과 불충분 시)

9단계: 필요 시 보충제 — 식품 우선 원칙